내 LDL 목표는 왜 남과 다를까요

'검진에서 정상'과 **'내 치료 목표'**는 다릅니다. LDL(나쁜 콜레스테롤) 목표는 내 혈관의 위험도에 따라 정해지고, **일찍 시작해 꾸준히** 낮출수록 혈관에 쌓이는 부담이 줄어듭니다.

목표는 위험도에 따라 다릅니다

나의 상황	LDL 목표
저위험 (위험인자 0~1개)	**160** mg/dL 미만
위험인자 2개 이상	**130** mg/dL 미만
당뇨 (10년 미만 · 위험인자·합병증 없음)	**100** mg/dL 미만
당뇨 (10년 이상, 또는 위험인자·합병증 중 하나라도)	**70** mg/dL 미만
경동맥 플라크* · 뇌졸중(뇌경색) 과거력* · 일과성 허혈발작(TIA)*	**70** mg/dL 미만
스텐트 · 심근경색 (+ 치료 전보다 50% 이상 감소)	**55** mg/dL 미만

검진 '정상' ≠ 내 목표 · NOTE

검진표의 **'정상'**으로 보이는 수치도 **내 치료 목표보다는 높을 수 있습니다.** 위험이 높을수록 목표를 더 낮게 잡습니다.

* 경동맥 플라크는 좁아진 정도와 전체 위험도를, 뇌경색·TIA는 원인(동맥경화 동반 여부)을 확인해 목표를 정합니다. 스텐트·심근경색은 55 미만과 함께 치료 전보다 LDL을 50% 이상 낮추는 것을 목표로 하며, 해당 고위험군에서도 50% 이상 감소를 함께 봅니다.

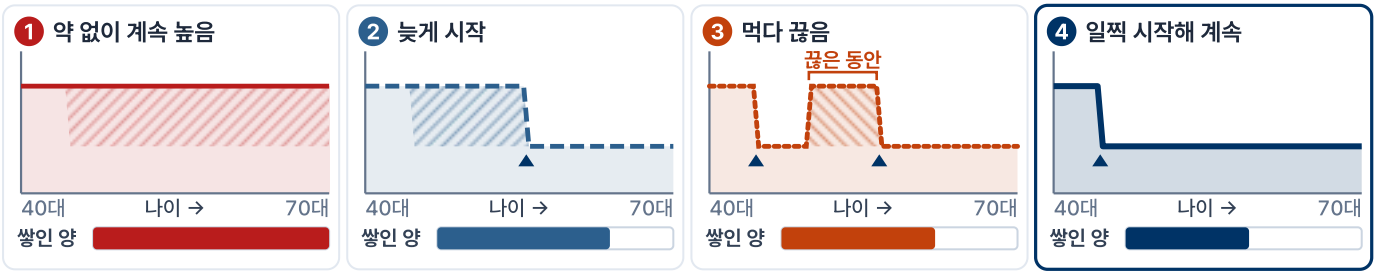
※ **2026 지침 선택 목표:** 재발 위험이 높은 뇌경색, 합병증이 있거나 위험인자가 3개 이상인 당뇨는 **55 미만**까지 낮추기도 합니다.

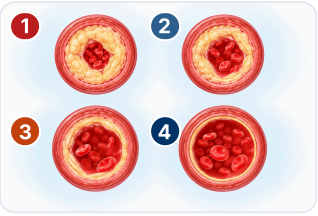
LDL은 간의 콜레스테롤 생성·처리 능력(유전적 요인)이 크게 좌우합니다

	LDL	중성지방
주로 정하는 것	음식보다 **간의 생성·처리 능력**	식사 · 술 · 체중
식사요법	모두에게 **기본 치료**	생활습관에 잘 반응합니다

식사요법(포화지방 줄이기)은 모두에게 **기본 치료**이고 **약과 함께 계속**합니다. 다만 LDL은 **간의 생성·처리 능력(유전 영향)**이 커서 식사만으로는 목표에 못 미치는 경우가 많습니다 — 이때 **약이 필요합니다.**

곡선 아래 넓이 = LDL 누적 노출(얼마나 높았는지 × 얼마나 오래였는지)





▲ 약 시작 ▨ 빗금 = ④보다 **더 쌓인 양** 막대 = 색칠된 넓이 전체 세로 LDL · 가로 나이

넓이가 클수록 혈관 벽 안쪽에 **찌꺼기(죽상경화반, plaque)**가 더 쌓여 피가 지나는 길이 좁아지고, 심근경색·뇌경색 위험이 커집니다.

혈관 단면 번호 = 위 그래프 번호(**① 가장 많이 → ④ 가장 적게**). ②·③ 순서는 시작 시기·끊은 기간에 따라 바뀔 수 있습니다. 이해를 돕는 그림이며 실제 수치가 아닙니다.

커피와 식단도 LDL을 움직입니다

아메리카노 · 라떼

에스프레소처럼 종이필터를 거치지 않은 커피에는 **LDL을 올리는 기름 성분(카페스톨)**이 남아 있습니다.

믹스커피 · 종이필터 드립

LDL 면에서는 **괜찮습니다.**

저탄고지

LDL에는 **가장 나쁜 식단**입니다.

흔한 오해 vs 사실

자주 듣는 오해 · MYTH	바로잡기 · FACT
"콜레스테롤은 몸에 꼭 필요하니 너무 낮추면 안 된다"	몸에 필요한 콜레스테롤은 **세포가 스스로 만듭니다.**
"러닝하면 고기 먹어도 된다"	운동으로 LDL은 크게 안 내려갑니다. **포화지방은 여전히 LDL을 올립니다.**
"오메가3로 LDL을 잡는다"	오메가3는 중성지방을 일부 낮추고 항염증 효과가 있지만, **LDL을 낮추지는 못합니다.**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 · 2026 ACC/AHA/Multisociety Dyslipidemia Guideline · EAS Consensus (Eur Heart J 2017) · LDL 누적 노출 (JACC 2020 · Nat Rev Cardiol 2024) · 커피 디테르펜 (Nutr J 2011) · 저탄고지 (Nutrients 2021)

본 자료는 일반 안내입니다. 개인별 LDL 목표와 약 조정은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

뒷면 → 콜레스테롤 약, 왜 일찍 · 왜 낮게 · 왜 계속 (심근경색·뇌경색을 겪은 분이 혼자 끊으면 안 되는 이유 포함)

콜레스테롤 약, 왜 일찍 · 왜 낮게 · 왜 계속일까요

혈관은 오늘 숫자 하나가 아니라 그동안 **LDL에 노출되어 쌓인 양**만큼 상합니다. 그래서 **일찍, 낮게, 끊지 않고.**

왜 일찍 Earlier is better · 빠를수록 좋다

2026 미국심장학회(ACC/AHA) 지침의 메시지입니다.

- **일찍 낮추면 평생 쌓이는 양이 적습니다**(앞면 그림 ④·②). 같은 양이라도 젊을 때 쌓이면 위험이 더 컸습니다.
- 건강한 성인 26년 추적 연구: LDL 160~189의 위험은 처음 10년엔 잘 안 보이다가 오래 지나 뚜렷해졌습니다.
- LDL이 높은 남성들(심장병이 없던 45~64세)이 약을 **5년쯤** 먹고 **20년** 지켜보니 가짜약 쪽보다 심장·혈관 병 사망이 **21% 적었습니다**(먼저 시작한 이득이 오래 남는 레거시 효과).
- 심장·혈관 병이 있던 분들은 추가 약(주사)을 처음부터 쓴 쪽이 2년쯤 늦게 쓴 쪽보다 심근경색·뇌졸중 같은 큰 병이 적었습니다.

> **기억할 점** 5년 일찍 시작한 이득은 그 5년에 그치지 않습니다. 늦게 시작하면 나중에 약을 써도 그 차이가 오래 남습니다. 약이 필요하다고 들었다면, 오늘이 쌓이는 양을 줄일 가장 빠른 날입니다.

왜 낮게 Lower is better · 낮을수록 좋다

- LDL을 약 **39 mg/dL** 더 낮출 때마다 심근경색·뇌경색 같은 큰 혈관 병이 **약 5분의 1(22%)씩** 줄었습니다(26개 연구·약 17만 명).
- 연구에서 확인한 LDL 범위에서는 낮을수록 위험이 더 낮았고 **"이 아래는 소용없다"는 바닥이 보이지 않았습니다.** 그 연구들에서 LDL이 아주 낮아져서 생긴 특별한 안전 문제도 없었습니다.

왜 계속 — 혈압약·당뇨약과 다른 점

비교	혈압약 · 당뇨약	콜레스테롤 약(스타틴)
많이 내려가면?	너무 낮아지면(저혈압·저혈당) **의사가 줄이거나 바꿉니다.**	**낮을수록 좋아서, 좋아졌다고 끊는 약이 아닙니다.** 좋아진 수치는 약이 일하고 있다는 뜻입니다. 위험이 높은 분들의 큰 연구에서도 많이 낮춰서 생긴 특별한 안전 문제는 없었습니다.
끊으면?	의사가 보고 조절하니 **혼자 끊지 않습니다.**	**2~3개월이면 약 먹기 전 수준**으로 올라 넓이가 다시 쌓입니다(앞면 그림 ③). 심근경색·뇌경색을 겪은 지 얼마 안 됐을 때 끊으면 결과가 더 나빴다는 보고가 있습니다. 끊기 전에 꼭 상의하세요.

약을 끊으면 나빠지는 것이 아니라 다시 올라갈 뿐입니다. 안경을 벗으면 다시 흐려지는 것과 같습니다.

> **기억할 점** 먹다 끊다를 반복해도 아예 안 먹는 것보다는 쌓이는 양(넓이)이 줄지만, 계속 먹을 때보다는 많이 쌓입니다. 그러니 약을 끊었다 다시 먹으며 스스로 시험해 보지 마세요.

주의 **가벼운 부작용도 혼자 끊지 말고 알려 주세요(양·약 조절). 임신** 계획이면 미리 상의하고, 임신이 확인되면 **약을 멈추고 바로 연락**하세요. **약을 먹는 동안은 모유 수유를 하지 않습니다.**

피검사로 이렇게 확인합니다

1 시작 전·시작	2 시작 4~12주 뒤	3 그다음	이럴 땐 바로
LDL·간 수치 측정. 위험도를 보고 **적은 양(저용량)부터** 시작할 수 있습니다.	피검사로 **목표 도달·간 수치 확인.** 못 미치면 용량을 올리거나 약을 더합니다.	괜찮으면 계속, **3~12개월마다** 피검사.	**심한 근육통·힘 빠짐, 콜라색 소변, 눈·피부가 노래짐, 이유 없는 심한 피로** → 약을 멈추고 바로 진료 (진료시간 밖이면 응급실). **숨쉬기 힘듦·얼굴·입술 붓기 → 시간과 관계없이 바로 119**

심근경색·스텐트·뇌경색이 있었다면 처음부터 센 약이 필요할 수 있습니다.

함께 보기 — 스타틴 오해와 사실·부작용 대처: edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/statin-myths-facts/

말초동맥질환(PAD)은 증상이 없어도 확진되면 혈관 위험 관리를 합니다. 강의의 PAD 목표는 LDL-C 70 mg/dL 미만, non-HDL-C 100 mg/dL 미만이며 서로 다른 지표입니다. 기존 심근경색·뇌졸중 등 개인 위험도도 함께 평가합니다. (아산28 김태오)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560 · 평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 이상지질혈증 진료지침 2026(한국지질·동맥경화학회: ACC/AHA 2026 요약·FOURIER-OLE·Cooper Center) · 2026 ACC/AHA 이상지질혈증 지침(Circulation 2026) · CTT 메타분석(Lancet 2010) · WOSCOPS 20년(Circulation 2016) · CARDIA(JACC 2020) · Ference(JACC 2012) · MedlinePlus

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/ldl-target-by-risk/